Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Amygdalectomie

Ablation des amygdales (totale ou partielle)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Technique prévue :
☐ Dissection à froid ☐ Diathermie (électrocoagulation)
☐ Radiofréquence / coblation ☐ Amygdalotomie (ablation partielle)

Actes supplémentaires au cours de la même intervention :
☐ Adénoïdectomie ☐ Aérateur(s) transtympanique(s) (yoyo)
☐ Aucun _____

Indication de l'opération (à remplir par le médecin) :
☐ Angines à répétition
☐ Troubles respiratoires du sommeil / ronflement
☐ Abcès péri-amygdalien (phlegmon de l'amygdale)
☐ Augmentation de volume d'un seul côté / diagnostic tissulaire
_____

Autre / remarques : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Les amygdales sont un tissu lymphoïde, appartenant au système de défense de l'organisme, situé de chaque côté de la gorge, au-dessus de la base de la langue. Après l'ablation des amygdales, le système de défense continue de fonctionner grâce aux autres tissus lymphoïdes de la bouche et de la gorge ; il n'a pas été démontré que l'opération affaiblit l'immunité.

L'amygdalectomie est le plus souvent recommandée en cas de : **angines (amygdalites)** récidivant plusieurs fois par an et entraînant des absences à l'école ou au travail ; amygdales hypertrophiées provoquant des **ronflements et des pauses respiratoires pendant le sommeil** ; **abcès autour de l'amygdale (phlegmon péri-amygdalien)** ; ou augmentation de volume d'une seule amygdale ou modification suspecte du tissu. Chez certains patients, la mauvaise haleine et les calculs amygdaliens peuvent aussi en être des raisons.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Le but de l'opération est de supprimer ou de réduire ces problèmes. Votre médecin vous expliquera séparément pourquoi l'opération est recommandée pour vous ou votre enfant.

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'opération est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire, par la bouche ; **il n'y a aucune incision ni cicatrice à l'extérieur.**

1. **Préparation :** Une fois l'anesthésie réalisée, un instrument spécial est mis en place pour maintenir la bouche ouverte et protéger la langue.
2. **Ablation des amygdales :** Chaque amygdale est séparée, avec la capsule qui l'entoure, de la couche musculaire sous-jacente, puis retirée. Selon la technique prévue, cela se fait avec des ciseaux et des instruments de dissection (dissection à froid), par électrocoagulation ou avec des appareils de radiofréquence/coblation.
3. **Ablation partielle (amygdalotomie) :** Chez certains patients, en particulier les jeunes enfants ayant des troubles respiratoires pendant le sommeil, seule la partie hypertrophiée de l'amygdale peut être retirée, en laissant une fine couche en place. Cette méthode peut entraîner moins de douleur et un risque de saignement plus faible ; cependant, le tissu restant peut repousser ou s'infecter.
4. **Contrôle du saignement :** Tout saignement dans les loges amygdaliennes est soigneusement arrêté par des points, des ligatures ou une électrocoagulation. Les loges amygdaliennes sont généralement laissées ouvertes et cicatrisent d'elles-mêmes.
5. **Actes supplémentaires :** S'ils sont prévus, l'ablation des végétations adénoïdes (adénoïdectomie) ou la pose d'aérateurs transtympaniques (yoyos) sont réalisées sous la même anesthésie ; des formulaires de consentement distincts sont remplis pour ces actes.
6. **Réveil et surveillance :** Après l'opération, le patient est surveillé en salle de réveil, puis dans le service, en ce qui concerne le saignement, la respiration et la prise de liquides.

Si le médecin le juge nécessaire, les amygdales retirées sont envoyées pour examen anatomopathologique.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 30–45 minutes (hors temps d'anesthésie)	Généralement une nuit d'hospitalisation pour surveillance

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une nette diminution des angines à répétition et de la fièvre, des maux de gorge, de la prise d'antibiotiques et des absences à l'école ou au travail qui y sont liés
- Moins de ronflements et moins de pauses respiratoires pendant le sommeil ; un sommeil de meilleure qualité et une amélioration de l'attention et du comportement pendant la journée
- La prévention des récidives d'abcès péri-amygdalien
- Si nécessaire, un diagnostic certain grâce à l'examen anatomopathologique du tissu

Chez des patients soigneusement sélectionnés, les infections de la gorge à répétition et les troubles respiratoires du sommeil s'améliorent dans une large mesure. Des infections de la gorge occasionnelles (pharyngites) peuvent encore survenir après l'opération, mais elles sont généralement moins fréquentes et plus légères. Si l'apnée du sommeil a aussi d'autres causes — comme un surpoids, la morphologie du visage ou une obstruction nasale —, les symptômes peuvent ne pas disparaître complètement et un traitement complémentaire peut être nécessaire.

4 Autres options thérapeutiques

- **Surveillance :** Si la fréquence des infections ne répond pas aux critères chirurgicaux ou si les symptômes sont légers, il peut être approprié d'attendre avec des contrôles réguliers. Chez l'enfant, les angines deviennent souvent moins fréquentes avec l'âge.
- **Antibiotiques et traitement symptomatique :** Chaque épisode infectieux continue d'être traité par des médicaments ; cela n'empêche pas de nouveaux épisodes.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Ablation partielle (amygdalotomie) :** Peut être envisagée à la place d'une ablation totale chez certains patients (voir explication ci-dessus).
- **Autres options pour l'apnée du sommeil :** Perte de poids, traitement de l'obstruction nasale, sprays nasaux à base de corticoïdes ou appareil de ventilation en pression positive continue (PPC) pendant le sommeil.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Sans opération, les angines à répétition, la fièvre, la prise d'antibiotiques et les absences à l'école ou au travail peuvent persister. Rarement, un abcès peut se former autour de l'amygdale ou l'infection peut s'étendre aux tissus du cou. Si une apnée du sommeil due à des amygdales hypertrophiées n'est pas traitée, elle peut — en particulier chez l'enfant — entraîner un retard de croissance et de développement, des troubles de l'attention et du comportement, une énurésie (pipi au lit) et, à long terme, une surcharge pour le cœur et les poumons. Dans les situations suspectes, comme une augmentation de volume d'un seul côté, ne pas opérer peut retarder un diagnostic certain.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang (en particulier des tests de saignement et de coagulation) et tout autre examen nécessaire sont réalisés avant l'opération, et vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Merci de nous signaler si vous-même ou un membre de votre famille avez tendance à saigner facilement, des saignements de nez fréquents, des règles abondantes ou prolongées, un saignement qui ne s'arrêtait pas après une extraction dentaire, ou un trouble de la coagulation connu.
- Aucun aliment solide ni lait ne doit être pris pendant les **6 heures** précédant l'opération ; pour les liquides clairs, respectez le délai indiqué par le médecin anesthésiste.
- Merci de nous signaler toute angine en cours, maladie avec fièvre ou grippe dans les 2–3 semaines précédant l'opération ; il peut être nécessaire de la reporter.
- Signalez à votre médecin toute dent qui bouge ou toute prothèse dentaire.
- Si vous venez de l'étranger, nous vous recommandons de rester à proximité de votre médecin et de l'hôpital pendant **au moins 10–14 jours** après l'opération (en raison du risque de saignement secondaire).
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Jour de l'opération	Vous aurez mal à la gorge au réveil ; la douleur est soulagée par des antalgiques. Une fois les éventuelles nausées passées, on donne de l'eau, puis des boissons fraîches ou tièdes et des aliments mous. Vous resterez à l'hôpital pour la nuit afin d'être surveillé(e) en ce qui concerne le saignement, la respiration et la prise de liquides.
1er–4e jour	

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	La douleur de gorge et la douleur irradiant vers les oreilles sont nettes. Une **couche blanc-jaunâtre** se forme sur les loges amygdaliennes ; elle fait normalement partie de la cicatrisation et n'est pas une infection. Une mauvaise haleine et une légère fièvre peuvent survenir. **Prendre régulièrement les antalgiques et boire beaucoup** sont les points les plus importants.
5e–10e jour	La couche blanche commence à se détacher. La douleur peut parfois augmenter à nouveau pendant cette période. **C'est la période où le risque de saignement secondaire est le plus élevé** ; évitez les efforts physiques intenses, les bains chauds/le sauna et les aliments durs, et consultez immédiatement au moindre signe de saignement.
10e–14e jour	La douleur diminue nettement et l'alimentation normale est reprise. La plupart des enfants retournent à l'école, et les adultes au travail, en 10–14 jours. Le sport et les activités physiques intenses sont généralement autorisés après environ 2–3 semaines.
3e–6e semaine	Les loges amygdaliennes cicatrisent complètement. Un examen de contrôle est réalisé ; si un examen anatomopathologique a été fait, le résultat est examiné.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Mal de gorge (dure généralement 7–14 jours ; plus marqué chez l'adulte que chez l'enfant)
- Douleur irradiant vers les oreilles (douleur projetée ; elle ne signifie pas qu'il y a un problème dans l'oreille)
- Difficultés à avaler et perte d'appétit ; une certaine perte de poids les premiers jours
- Couche de cicatrisation blanc-jaune sur les loges amygdaliennes et mauvaise haleine
- Légère fièvre (les premiers jours), nausées et vomissements dus à l'anesthésie
- Gonflement temporaire de la langue et de la luette

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Saignement après l'opération (saignement secondaire)** — Survient chez environ **2–5 patients sur 100**, le plus souvent **5 à 10 jours après l'opération**, lorsque la couche de cicatrisation se détache. Il est un peu plus fréquent chez l'adulte que chez l'enfant. La plupart des saignements sont minimes et s'arrêtent avec une surveillance, de la glace, un traitement local dans la bouche ou un geste simple.
- **Retour au bloc opératoire pour saignement** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, un **retour au bloc opératoire sous anesthésie générale** peut être nécessaire pour arrêter le saignement. La durée d'hospitalisation peut alors être plus longue.
- **Apport insuffisant de liquides et déshydratation** — Si la quantité de liquides bue est insuffisante à cause de la douleur, une fatigue et une diminution des urines peuvent survenir, en particulier chez le jeune enfant ; une hospitalisation pour perfusion est parfois nécessaire.

Situations peu fréquentes

- **Transfusion sanguine** — Si la perte de sang lors d'un saignement est importante, une transfusion sanguine peut être nécessaire ; cela survient chez **bien moins de 1 patient sur 100**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Trouble du goût et engourdissement de la langue** — La langue étant maintenue sous pression par l'instrument pendant l'opération, une modification du goût ou un engourdissement de la langue peuvent survenir ; cela s'améliore généralement en quelques semaines, mais peut rarement durer des mois ou être définitif.
- **Lésions des dents, des lèvres et de la langue** — La pression de l'instrument utilisé pour maintenir la bouche ouverte peut ébrécher une dent (en particulier une dent qui bouge ou qui est cariée), ou provoquer une petite brûlure, une plaie ou un gonflement des lèvres ou de la langue.
- **Infection** — Une infection peut se développer dans les loges amygdaliennes ou dans le cou ; elle est généralement traitée par antibiotiques.
- **Voix nasonnée temporaire** — Les mouvements du voile du palais étant limités par la douleur, de l'air peut temporairement s'échapper par le nez lors de la parole ; cela disparaît généralement en quelques semaines.
- **Repousse après amygdalotomie** — En cas d'ablation partielle, le tissu amygdalien restant peut repousser ou s'infecter (chez environ **1–6 patients sur 100**) ; rarement, une amygdalectomie totale peut alors être nécessaire.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Saignement grave et ses conséquences** — Rarement, le saignement peut être abondant et rapide. Dans ce cas, **une chirurgie d'urgence, une transfusion sanguine** et, très rarement, des gestes supplémentaires sur les vaisseaux sanguins du cou peuvent être nécessaires. Une perte de sang importante ou le passage de sang dans les voies respiratoires peuvent entraîner des conséquences graves telles qu'**une insuffisance respiratoire, la nécessité d'une prise en charge en réanimation** et des séquelles définitives qui en résultent.
- **Complications mettant la vie en danger et décès** — Le décès lié à une amygdalectomie est extrêmement rare ; il est rapporté dans la littérature médicale à environ **1 cas pour 15 000–35 000 opérations**. Les causes les plus fréquentes sont un saignement grave et des problèmes respiratoires. Les jeunes enfants atteints d'apnée du sommeil sévère ont un risque plus élevé de problèmes respiratoires après l'opération ; ces patients sont donc surveillés plus étroitement.
- **Voix nasonnée définitive / reflux de liquides par le nez (insuffisance vélopharyngée)** — Très rare ; observée principalement chez les personnes ayant une fente palatine cachée. Une rééducation orthophonique ou, rarement, une opération de correction peut être nécessaire.
- **Glissement des vertèbres cervicales (syndrome de Grisel), infection s'étendant au cou ou au thorax** — Affections très rares, qui peuvent être traitées si elles sont reconnues tôt. Elles peuvent se manifester par une douleur du cou qui s'aggrave progressivement, une impossibilité de tourner la tête, une forte fièvre et une impossibilité d'avaler. Si elles surviennent, une hospitalisation, des antibiotiques par voie intraveineuse et, si nécessaire, un drainage chirurgical sont nécessaires ; si le traitement est retardé, des problèmes durables du cou peuvent apparaître ou une infection qui s'étend peut mettre la vie en danger.
- **Cicatrices et rétrécissement de la gorge et du palais** — Très rarement, un tissu cicatriciel excessif peut se former pendant la cicatrisation, rétrécir la gorge ou le palais et entraîner des difficultés à avaler ou à parler.
- **Douleur ou luxation de l'articulation de la mâchoire** — Survient très rarement en raison du maintien prolongé de la bouche ouverte.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Sang frais, rouge** par la bouche, crachats ou vomissements de sang — **même quelques gouttes** — consultez sans attendre. En cas de saignement, penchez la tête en avant et crachez le sang au lieu de l'avaler ; vous pouvez vous gargariser à l'eau froide.
- Chez l'enfant : **déglutitions fréquentes**, pâleur, grande fatigue, difficulté à se réveiller (peut être le signe que du sang a été avalé)
- **Difficultés respiratoires**, pauses respiratoires marquées pendant le sommeil, respiration bruyante
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, ou douleur qui ne cède pas aux antalgiques ou qui ne cesse d'augmenter
- Refus total de boire, absence d'urines depuis 8 heures, somnolence inhabituelle (signes de déshydratation)
- Douleur du cou qui s'aggrave progressivement, impossibilité de tourner la tête, gonflement du cou

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Contre la douleur, utilisez uniquement **les antalgiques recommandés par votre médecin**, aux doses et intervalles recommandés, et **prenez-les régulièrement**. L'aspirine et les autres antalgiques non recommandés par votre médecin peuvent augmenter le risque de saignement ; n'ajoutez aucun médicament de vous-même.
- **Boire beaucoup** est la règle la plus importante. L'eau fraîche ou tiède, l'ayran (boisson au yaourt), les compotes, la glace, les crèmes dessert au lait, le yaourt et les purées conviennent. Évitez pendant environ **2 semaines** les aliments très chauds, acides, épicés et durs/croustillants (chips, crackers, pain grillé).
- Pendant les 2 premières semaines, évitez les efforts physiques intenses, les bains chauds, le sauna et les expositions prolongées au soleil.
- Vous pouvez continuer à vous brosser les dents ; évitez tout contact brusque avec la gorge.
- Nous vous recommandons de reporter votre vol de retour à l'étranger jusqu'à ce que le risque de saignement secondaire soit passé (généralement **10 à 14 jours après l'opération**). Si vous devez prendre l'avion plus tôt, discutez des risques avec votre médecin.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ On m'a clairement expliqué qu'**un saignement secondaire peut survenir** au cours des 2 premières semaines suivant l'opération, en particulier entre le 5e et le 10e jour ; que dans ce cas je dois contacter le médecin ou me rendre sans attendre au service d'urgences le plus proche ; et qu'un saignement peut nécessiter une nouvelle opération, une transfusion sanguine et, rarement, une prise en charge en réanimation.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.